Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Peu ou pas d’urines / globe vésical

Protections sèches, envie d’uriner sans y arriver, bas-ventre tendu, ou agitation inexpliquée. EHPAD, MAS-FAM, IME.

URGENCE VITALE → APPEL 15 IMMÉDIAT · pas d’urines avec malaise, somnolence inhabituelle, marbrures ou sueurs ; ventre douloureux avec vomissements.

1 · Je sécurise

- Rassurer ; proposer d’uriner au calme, dans la position habituelle.
- Sonde à demeure : tuyau **non coudé**, poche **plus bas que la vessie**.
- Agitation ou confusion récente : **penser à la vessie** avant de conclure à un trouble du comportement.

2 · J’observe et je mesure

- Heure de la **dernière miction** ; protections **sèches** à 2 changes de suite ?
- Boule tendue et douloureuse au-dessus du pubis ? Petites fuites permanentes (trop-plein) ?
- Boissons des dernières 24 h, chaleur, vomissements, diarrhée ? Urines foncées, rouges, odorantes ?
- Constantes, **température** ; douleur (EN, Algoplus, échelle habituelle) ; **dernières selles** (fécalome ?).

3 · J’agis

- Prévenir l’IDE : **bladder scan**, bandelette urinaire, décision de sondage.
- A peu bu, sans ventre tendu : proposer à boire (texture adaptée), sauf restriction prescrite.
- Tenir un relevé : boissons, mictions ou protections mouillées, avec les heures.
- Nuit sans IDE : IDE d’astreinte, sinon médecin d’astreinte ; personne de joignable → 15.

Je ne fais pas

- **Sonder** : geste infirmier, jamais AS ni éducateur.
- Appuyer sur le ventre pour faire uriner.
- Clamper, retirer ou changer une sonde urinaire.
- Forcer à boire une personne au ventre tendu.

J’alerte

Appel 15 immédiat si :

- Pas d’urines **et** malaise, somnolence, marbrures, sueurs ou PAS < 100 mmHg.
- Bas-ventre très douloureux, IDE et médecin d’astreinte injoignables.

J’appelle l’IDE (à défaut : médecin d’astreinte ou DOTR) si :

- **Sans attendre** : aucune urine depuis 6 h malgré des boissons suffisantes, ou protections sèches à 2 changes.
- Boule douloureuse au-dessus du pubis, envie sans pouvoir uriner, fuites permanentes.
- Fièvre ≥ 38 °C, urines rouges, agitation ou confusion nouvelle ; sonde qui ne coule plus.

Je surveille et je trace

- Chaque miction ou change (sec / mouillé) et chaque boisson, jusqu’à l’avis IDE.
- Après sondage par l’IDE : couleur des urines, douleur, température, comportement.
- Tracer : dernière miction, constatations, constantes, qui a été prévenu.

Mention de sécurité

Pas d’urines = IDE sans délai (vessie pleine ou déshydratation). L’AS ne sonde jamais ; l’IDE contrôle au bladder scan.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : ARS IDF/STARAQS, guide ESMS handicap fiches 0 et 20 (seuils 6 h / 2 changes, 2023) ; ASSURE IDF, fiche 19 « Peu ou pas d’urines » (2023) ; Urg’ARA/ARS ARA, EHPUR (MAJ 07/2025) ; arrêté du 26/06/2026 (bladder scan : rôle propre IDE ; sondage : IDE sur prescription ou protocole ; actes AS/AP/AES).

Réf. DOTR-AS-GLOBE | Version 1.0 – 10/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature